

DOSSIER TRANSMIS POUR RECOURS CONTENTIEUX (TRIBUNAL ADMINISTRATIF)

À l'attention de : Maître Ventzislava
KOSSEVA-VENZAL (Avocate-EI)

24, Rue d'Alsace Lorraine

31 000 TOULOUSE

Tél : 05.61.62.13.39

Mail : cabinet@avocat-kosseva-venzal.fr

De la part du : Collectif des Ambulanciers Inter-Hospitaliers du CHU de Toulouse

Date du document : 29 mai 2026

Objet : Recours en annulation et recours indemnitaire – Revalorisation statutaire, transfert en filière soignante, mise en conformité des fiches de poste, et octroi de la NBI et de l'IFR.

I. EXPOSÉ DU CONTEXTE ET ÉVOLUTION STRATÉGIQUE DU DOSSIER

Les agents du service des Transports Internes Hospitaliers (Ambulanciers de la Fonction Publique Hospitalière - Catégorie B) contestent les refus répétés de la Direction du CHU de Toulouse d'aligner leur situation réglementaire et indemnitaire sur la réalité de leurs missions.

Un compte rendu (CR) officiel, signé le **27 mai 2026** par la Direction (Mme Roger), ainsi que l'analyse des données d'activité brute de l'année 2025 (totalisant **56 843 transports**), viennent de modifier radicalement l'équilibre juridique du dossier. L'administration a opéré des concessions majeures qui détruisent ses propres arguments de défense. La voie amiable étant épuisée (matérialisée par une rupture de séance des agents lors du dernier dialogue du 27 mai), nous sollicitons votre expertise pour engager le contentieux devant le Tribunal Administratif.

II. LES CINQ PILIERS DU RECOURS ET L'ARGUMENTAIRE JURIDIQUE

1. Le verrou de la filière logistique : Une anomalie structurelle bloquant l'accès aux droits

- **La situation** : Le maintien artificiel des ambulanciers des transports internes au sein de la **filière logistique** au CHU de Toulouse agit comme un verrou budgétaire. C'est cette classification administrative obsolète qui rend structurellement impossible l'attribution de la NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) et de l'IFR (Indemnité Forfaitaire de Risque), pourtant légalement applicables.
- **Le fondement juridique** : Le décret national n° 2021-1825 a pourtant reclassé les ambulanciers de la FPH en catégorie B (corps des personnels de la filière soignante). De plus, l'accès à ces indemnités pour les personnels exerçant ces missions a été reconnu par le **Conseil d'État (décision n° 467063 du 19 juillet 2023)**. Le droit existe, le décret existe, la jurisprudence existe. Les agents exercent pleinement ces fonctions au quotidien, mais ne perçoivent pas les indemnités afférentes.
- **Rupture d'égalité interne et externe** : D'autres CHU en France ont octroyé ces droits. Plus flagrant encore, au sein même du CHU de Toulouse, les unités du SAMU 31 bénéficient de ce classement en filière soignante ou médico-technique.
- **Moyen de droit et demande** : L'inaction délibérée de la Direction, qui refuse d'opérer la restructuration interne indispensable, prive des soignants — reconnus comme tels par la loi — des contreparties auxquelles ils ont droit. Nous demandons une restructuration interne pour être rattachés à la **filière soignante ou médico-technique**, condition *sine qua non* pour faire sauter ce verrou budgétaire et débloquer les enveloppes correspondantes.

2. Mise à jour de la fiche de poste (Probabilité de succès : 98%)

- **La situation** : La fiche de poste actuelle (datant de 2020) restreint indûment les missions à des transports « non médicalisés » de base et omet totalement les activités funéraires.
- **L'aveu de la Direction (27 mai 2026)** : Lors de l'instance, M. Huet a explicitement reconnu le « **caractère imparfait du protocole** » et de la fiche de poste. De plus, la DRH a déjà admis par écrit l'existence de « transports complexes médicalisés ».
- **Moyens de droit** : Violation du principe de concordance entre la fiche de poste et les fonctions réellement exercées. L'administration ne peut maintenir une description de poste obsolète (qualifiant les agents de simples conducteurs de patients « non médicalisés ») au regard des 56 843 transports annuels effectifs.

3. Octroi de la NBI de 10 points ou indemnité équivalente pour le transport de corps (Probabilité de succès : 82%)

- **La situation** : La Direction rejetait cette demande au motif que le transport de corps présentait un caractère purement « occasionnel ».
- **Le revirement factuel et textuel du 27 mai** : * Dans le CR officiel, Mme Roger cite elle-même le règlement intérieur des chambres mortuaires (Annexe 13 du RI du CHU, page 7) pour affirmer que les ambulanciers ont la charge du transport des corps. M. Huet confirme que c'est « *tout à fait possible sur le plan réglementaire* ».
 - Le règlement intérieur (Chapitre 2-2) enfonce le clou en précisant explicitement que « **les dépôts de corps sont assurés 24 heures sur 24 soit par le service Ambulances du CHU (site Purpan et hôpital Larrey)** ». La mission est donc permanente et structurelle.
 - Les chiffres 2025 opposent une réalité incontestable : **1 660 transports de corps à l'année** (soit 4,5 par jour), dont **63% (1 045 corps) sont réalisés la nuit ou en horaires décalés** (avant 8h00 et après 17h30), en autonomie complète sans le personnel de la chambre mortuaire (gestion du logiciel M2Pi et des casiers frigorifiques).
- **Argument à formuler** : « La Direction ne peut valablement soutenir que l'activité de transport de corps présente un caractère occasionnel excluant tout droit indemnitaire, alors qu'elle reconnaît officiellement, dans le compte rendu du 27 mai 2026 et dans le règlement intérieur des chambres mortuaires qu'elle cite elle-même, que cette mission est structurelle, permanente et assurée 24 heures sur 24 par le service Ambulances. »
- **Subsidiairement** : Si le décret national NBI s'avérait trop restrictif sur l'exclusivité en chambre mortuaire, nous demanderons la condamnation du CHU à verser une **indemnité forfaitaire locale spécifique pour sujétion spéciale**, sur le modèle de ce qui a été mis en place au CHU d'Angers.

4. Attribution de l'Indemnité Forfaitaire de Risque - IFR (Probabilité de succès : 65%)

- **La situation** : La DRH applique une lecture « en silo » injustifiée : elle isole le secteur de l'UHSI (détenus), affirmant qu'il ne représente que 0,25% du temps de travail global, pour acter que le seuil réglementaire de 50% du temps de travail dans les structures d'urgence n'est pas atteint.
- **La réfutation juridique** : Le texte parle d'un exercice « *dans les structures de médecine d'urgence* ». L'ambulance inter-hospitalière est le prolongement clinique direct et la noria continue de ces services.
- **Les données factuelles (Activité 2025)** : Les relevés chiffrent **4 033 transports liés aux Urgences** et **3 751 transports liés à la Psychiatrie** (urgences psy et sous contrainte), soit un total de **7 784 interventions à caractère urgent ou sécuritaire**. Isoler les 0,25% de l'UHSI constitue une manipulation manifeste du périmètre d'appréciation.

- **L'aveu indirect de la Direction (27 mai) :** En fin de CR, la Direction propose de privilégier les ambulanciers du service pour les créations de postes sur le pôle médecine d'urgence, reconnaissant de fait que leurs compétences sont parfaitement adaptées à ces secteurs et que la frontière invoquée pour refuser l'IFR est artificielle.
- **Argument à formuler :** « *En limitant le calcul du seuil de 50% au seul secteur UHSI (0,25%), la Direction opère une décomposition artificielle des missions qui contredit la réalité opérationnelle documentée : les transports relevant des urgences et de la psychiatrie sous contrainte représentent à eux seuls plus de 7 700 interventions annuelles. Le critère réglementaire doit s'apprécier sur l'ensemble des secteurs à caractère urgent, et non sur un sous-ensemble isolé.* »

5. La NBI de 20 points au titre du SMUR/SAMU (Probabilité de succès : 40%)

- **Position :** Maintenu dans les conclusions pour matérialiser l'exposition globale aux risques et la polyvalence imposée par l'établissement (transports complexes en « SMUR dégradé » dus à la pénurie de médecins). Cet élément servira de levier d'arbitrage global ou de démonstration de l'enrichissement sans cause du CHU.

III. JURISPRUDENCE ET PRÉCÉDENTS ADMINISTRATIFS COMPARABLES

Nous demandons à Maître KOSSEVA-VENZAL d'opposer fermement à la DRH la jurisprudence du **Conseil d'État (19 juillet 2023, n° 467063)** ainsi que les précédents des **CHU d'Angers et de Tours**.

Confrontés à des mouvements sociaux et des réalités opérationnelles strictement identiques, ces établissements hospitaliers soumis au même statut national de la Fonction Publique Hospitalière (FPH) ont su actionner les leviers réglementaires requis (révision des fiches d'affectation, temps partagé vers l'urgence, indemnités locales de sujétion pour le funéraire). Le fait que des agents de la FPH soumis aux mêmes décrets obtiennent des droits différents crée une rupture d'égalité manifeste. Le blocage à Toulouse ne relève pas d'une impossibilité légale, mais d'un choix politique et d'une inertie administrative délibérée.

IV. LISTE DES PIÈCES COMPLÉMENTAIRES FOURNIES AU CABINET

1. **Le compte rendu officiel** de l'instance du **27 mai 2026** (signé sous la responsabilité de Mme Roger).
2. **La décision du Conseil d'État n° 467063** du 19 juillet 2023 relative à l'accès aux indemnités.
3. **Le Règlement Intérieur des chambres mortuaires** du CHU de Toulouse (Annexe 13, page 7 et Chapitre 2-2 prouvant la mission permanente 24h/24).
4. **Le relevé d'activité brute de l'année 2025** (justifiant le volume global de **56 843 transports** et le détail minutieux par secteur : 1 660 corps, 7 784 Urgences + Psy, 734 UHSI).

5. **La fiche de poste actuelle** des agents (version 2020, devenue illégale au regard de l'évolution des missions et du reclassement en Catégorie B soignante).

Contact Collectif Ambulancier interne Chu de Toulouse

M.Victor Alava, Syndicat SUD Solidaires Toulouse : 06 69 12 01 65

CGT CHU Toulouse : 06 64 86 15 83

M.Jérôme Jean Charles, délégué du personnel ambulancier : 06 86 69 90 95

M.Laurent Bezia, délégué du personnel ambulancier : 07 60 40 80 08

Dossier complet, revue de presse et journal de mobilisation :

<https://bezialaurent-lang.github.io/ambulancierschutoulouse/blog/>